

中西药合用治疗中重度痤疮临床研究

龙 静

(四川省金堂县中医医院皮肤科, 四川 成都 610400)

[中图分类号] R758.733 [文献标识码] B [文章编号] 1004-2814 (2023) 09-1795-03

[摘要] 目的: 观察中西药合用治疗中重度痤疮的临床疗效。方法: 50例分为对照组和实验组各25例, 对照组用清热散结胶囊联合外用阿达帕林凝胶, 实验组用中药联合外用阿达帕林凝胶。结果: 实验组总有效率高于对照组 ($P < 0.05$)。两组治疗后日常生活、人际关系及治疗评分均下降, 且实验组低于对照组 ($P < 0.05$)。两组治疗4周及8周时GAGS评分均有下降, 治疗8周时实验组GAGS评分低于对照组 ($P < 0.05$)。实验组不良反应低于对照组 ($P < 0.05$)。两组复发率比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。结论: 中西药合用治疗中重度痤疮可提高疗效, 且安全性好。

[关键词] 中重度痤疮; 中西药合用; 对照治疗观察

中重度痤疮(Ⅱ级、Ⅲ级)是指有大量丘疹、脓疱, 皮损总数在50个上下, 结节数少于3个。身上及面部可能发生一些不可逆的瘢痕、色素沉着^[1-2]。中医辨证治疗具有一定优势^[3]。本研究以中西药合用治疗中重度痤疮疗效较好, 报道如下。

1 临床资料

共50例, 均为2023年1月至2023年3月本院治疗患者, 分为对照组和实验组各25例。对照组男10例, 女15例; 年龄18~38岁, 平均(27.18 ± 2.39)岁; 平均病程(2.74 ± 0.29)年。实验组男10例, 女15例; 年龄17~39岁, 平均(28.81 ± 2.27)岁; 平均病程(2.18 ± 0.59)年。两组一般资料比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

诊断标准: ①符合《临床皮肤病学》^[4]中重度痤疮诊断标准。痤疮以白头粉刺、黑头粉刺、炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿等为主要表现, 常伴皮脂溢出, 好发于面部及上胸背部。②符合《中医外科学》中肺胃热盛(皮疹好发于颜面部, 胸背部可见少量皮疹, 皮损以红色丘疹为主, 个别上有脓头, 痒痛相兼, 舌红苔薄白或薄黄, 脉滑或滑略细, 大便干结), 冲任失调(皮损集中在颜面部, 以暗红色的丘疹、结节为主, 时有疼痛, 舌淡苔薄白, 脉滑或细, 伴有月经不调, 常夹杂血块)证型诊断标准^[5]。

纳入标准: 对治疗方式及药物无过敏反映, 治疗依从性较好。

排除标准: 肝、肾功能不全, 心理障碍或精神疾病, 已经开始口服糖皮质激素、异维A酸, 孕妇、哺乳期, 有高血脂症。

2 治疗方法

对照组: 用清热散结胶囊联合外用阿达帕林凝胶治疗。清热散结胶囊(主要成分为千里光, 湖南天济草堂制药股份有限公司生产, 国药准字Z20133038, 规格为每粒0.33g)口服, 每次4~6粒, 日3次。阿达帕林凝胶[主要成分为阿达帕林, 江苏福邦药业有限公司生产, 国药准字H20113373, 规格为0.1%(30g: 30mg)]每晚1次, 点涂。根据临床效果及不良反应调整药量。

实验组: 用中药联合阿达帕林凝胶治疗。肺胃热

盛型用枇杷清肺饮加减。枇杷叶15g, 桑白皮10g, 黄芩10g, 生地10g, 牡丹皮10g, 川芎10g, 焦山楂10g, 大黄5g。额部皮疹较多加野菊花、蒲公英、决明子, 部位以口周为主加栀子、藿香各10g。冲任失调型用柴胡清肝汤加减。当归、白芍、生地黄、川芎、黄芩、白花蛇舌草、菟丝子、茯苓、柴胡。2日1剂, 1剂煎3次, 煎至600mL, 每天3次, 每次100mL, 2天服完。阿达帕林凝胶用法同对照组。

两组均治疗1个月。

3 观察指标

皮肤病生活质量: 应用皮肤病生活质量指数(DLQI)进行评价^[7], 主要包括3个项目, 共10个问题, 各问题0~3分, 分值越高表明生活质量越差。

不良反应发生情况: 主要包括皮肤黏膜干燥、肝酶升高以及白细胞下降。

痤疮综合分级系统(GAGS) 评分治疗前及治疗结束后评分差异, 各区总分值=因素分值×皮损分值, 不同分区总分之和为综合分值。

复发情况: 电话随访3个月, 每个月随访1次, 根据治疗后结束时和治疗结束后每个月对面部潮红、脓疱等情况进行比较, 根据随访记录进行统计。

用SPSS21.0软件分析, 计量资料以($\bar{x} \pm s$)表示、用 t 检验, 计数资料以(%)表示、用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

4 临床疗效

按《中药新药临床研究指导原则》^[6]。显效: 临床症状及皮肤损伤消失。有效: 临床症状得到缓解, 皮肤损伤消退80%以上。无效: 病情尚未改善, 皮肤损伤无明显变化。

5 治疗结果

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

组别	例	显效	有效	无效	总有效率
对照组	25	12(48)	5(20)	8(32)	(68)
实验组	25	18(72)	6(24)	1(4)	(96)
χ^2					4.878
P					0.027

两组治疗前后DLQI评分比较见表2。

表2 两组治疗前后DLQI评分比较 (分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例	日常生活		人际关系		治疗	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	25	2.96 ± 0.28	2.26 ± 0.83*	2.65 ± 0.43	1.83 ± 1.02*	2.72 ± 0.77	2.58 ± 0.53*
实验组	25	2.84 ± 0.13	1.37 ± 0.26*	2.82 ± 0.21	1.08 ± 0.56*	2.55 ± 0.73	1.74 ± 0.39*
<i>t</i>		1.944	5.116	1.776	3.223	0.801	6.383
<i>P</i>		0.058	<0.001	0.082	0.002	0.427	<0.001

注:与本组治疗前比较,* $P < 0.05$ 。

两组治疗前后GAGS评分比较见表3。

表3 两组治疗前后GAGS评分比较 (分, $\bar{x} \pm s$)

组别	例	治疗前	治疗4周	治疗8周
对照组	25	77.57 ± 5.63	39.72 ± 12.64*	36.88 ± 11.53*
实验组	25	78.24 ± 6.02	54.68 ± 11.77*	24.66 ± 10.69* [△]
<i>t</i>		0.406	4.331	3.886
<i>P</i>		0.686	<0.001	<0.001

注:与本组治疗前比较,* $P < 0.05$;与治疗8周时比较,[△] $P < 0.05$ 。

两组不良反应发生情况比较见表4。

表4 两组不良反应发生情况比较 例 (%)

组别	例	皮肤黏膜干燥	肝酶升高	白细胞下降	发生率
对照组	25	7 (28)	1 (4)	0 (0.00)	(32)
实验组	25	1 (4)	0 (0.00)	0 (0.00)	(4)
χ^2					4.878
<i>P</i>					0.027

两组复发情况。治疗后对照组有5例(20%)出现面部潮红加重、面部脓疱数量增加情况。治疗后实验组有1例(4%)面部潮红加重、面部脓疱数量增加。两组复发率比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。

6 讨论

中重度痤疮是一种毛囊、皮脂腺的慢性炎症,主要发生在颜面及胸背等多脂区。有自限性,皮损多样,如粉刺、丘疹、脓疱、结节^[8]。

研究证实,联合使用作用机制不同的治疗药物,可使副作用降低,治疗作用相加或协同,从而达到最大的效应比^[9-11]。中医辨证治疗抓住病机的基本特点,分清寒、热、虚、实,局部辨证与整体辨证相结合^[12]。可以针对不同患者的情况进行恰当的药物搭配,实现恰到好处的治疗效果。如对于面部痤疮以红色丘疹、粉刺和脓疱为主,伴油腻和少许红色结节,口干、心烦、失眠、便干溲赤、舌红苔黄及脉数者,应宣肺泻热,用枇杷清肺饮加减^[13-14]。对皮疹色红,伴有宿食不消、脘腹胀满、大便秘结、舌红苔黄腻、脉滑数或濡数者,应清热化食通腑,用二陈汤合茵陈蒿汤加减。对于痤疮发生和轻重与月经周期明显有关,常伴有月经不调、情志不舒、乳房胀痛等不适,舌红苔微黄,脉弦细数,应养血疏肝清热除湿,方用柴胡清肝汤加减^[15]。

阿达帕林是通过抑制皮脂腺产生和影响皮脂腺上皮细胞分化作用,减少油脂分泌,并使上皮过度角质化的细胞脱落,从而减轻毛囊堵塞,减少粉刺的形成,并抑制白细胞的趋化反应和炎症介质的产生达到抗炎作用,所以其适用于中重度痤疮,尤其是结节型、囊肿型、聚合型痤疮^[16-17]。对于中重度痤疮阿达帕林还可以预防或改善痤疮后的瘢痕及减轻色素沉着。阿达帕林作为一种外用的维A酸类药物,仍然有一定的不良反应,如皮肤刺激、光敏感,虽然经皮吸收很少,但是妊娠期及哺乳期妇女慎用。

中西药合用治疗中重度痤疮可提高疗效,且安全性好。

[参考文献]

- [1] 陈薇,秦璇,田二云.夫西地酸乳膏联合阿达帕林凝胶治疗寻常痤疮的疗效[J].武警医学,2022,33(6):510-511.
- [2] 陈红霞,张虹亚,王建锋,等.纳晶微针联合中药面膜治疗痤疮凹陷性瘢痕的临床疗效和安全性研究[J].中华中医药学刊,2020,38(6):214-217.
- [3] 刘岩,王浩,张晓茹,等.百癣夏塔热片联合阿达帕林凝胶治疗寻常痤疮的疗效观察[J].河北医学,2020,26(3):445-450.
- [4] 罗汉超.喜读《临床皮肤病学》第3版[J].临床皮肤科杂志,2002,31(1):60.
- [5] 李曰庆.中医外科学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2008:191.
- [6] 梁茂新,高天舒.《中药新药临床研究指导原则》脏腑诸证考察与分析[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(5):330-331,342.
- [7] 王晓玲,袁玲玲,赵天恩.皮肤病生活质量指数的研究进展[J].国外医学(皮肤性病学分册),2004,30(2):85-87.
- [8] 刘黛娜,李小林.新型复合酸联合阿达帕林凝胶治疗轻中度寻常痤疮疗效评估[J].现代医学与健康研究(电子版),2022,6(4):53-55.
- [9] 刘晓莉.阿达帕林凝胶辅助超分子水杨酸,类人胶原蛋白敷料治疗轻中度痤疮患者的效果观察[J].河北医科大学学报,2021,42(10):1189-1193,1209.
- [10] 冯静,周慧.中西医结合联合强脉冲光治疗玫瑰痤疮的临床疗效[J].中国激光医学杂志,2022,31(5):281-287.
- [11] 陈姣,王子雯,许孟月,等.中医学从“热”和“郁”角度治疗痤疮研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2022,24(6):160-164.
- [12] 张君冬,张益生,刘欣源,等.基于文献挖掘及复杂网络探讨寻常性痤疮常见中医证型及核心用药规律[J].世界科学技术-中医药现代化,2021,23(11):4230-4236.
- [13] 赵东瑞,赵杭.新析痤疮因证论治[J].浙江中医药大学学报,2020,44(10):949-955.
- [14] 白书仙,张波,张洁,等.痤疮肝郁脾虚证临床研究[J].陕西中医,2021,42(3):344-346.
- [15] 王庆兴,郭雪枫.中药联合火针治疗囊肿结节型痤疮临床观察[J].光明中医,2018,33(2):243-245.
- [16] 陈薇,秦璇,田二云.夫西地酸乳膏联合阿达帕林凝胶治疗寻常痤疮的疗效[J].武警医学,

黄芪建中汤加味联合奥美拉唑治疗 消化性溃疡脾胃虚寒型临床观察

张军帅¹, 李 宁²

(1.河南省长垣中西医结合医院, 河南 长垣 453400; 2.河南省中西医结合医院, 河南 郑州 450003)

[中图分类号] R573.1 [文献标识码] B [文章编号] 1004-2814 (2023) 09-1797-03

[摘要] 目的: 观察黄芪建中汤加味联合奥美拉唑治疗消化性溃疡脾胃虚寒型的效果。方法: 70例随机分为两组各35例, 两组均用奥美拉唑治疗, 观察组加用黄芪建中汤加味治疗。结果: 观察组总有效率高于对照组 ($P < 0.05$)。结论: 黄芪建中汤加味联合奥美拉唑治疗消化性溃疡脾胃虚寒型可提高疗效。

[关键词] 消化性溃疡; 脾胃虚寒型; 黄芪建中汤; 奥美拉唑

消化性溃疡是因胃和十二指肠黏膜在胃蛋白酶和胃酸的作用下发生溃疡, 导致溃疡的原因与黏膜保护和黏膜受损失去平衡有关, 也与患者个人卫生、年龄、生活习惯、家族史有关^[1]。治疗通常给予质子泵抑制剂、保护胃黏膜药治疗, 长期服用抑制胃酸药物会产生耐药性, 影响症状改善^[2]。消化性溃疡属“胃脘痛”、“呕吐”、“痞满”范畴。与饮食不节、情志不畅、外邪犯胃有关。治疗以补益脾胃、理气和胃为主。黄芪建中汤和中缓急、温中补气, 有抑制胃酸、调节黏膜代谢、促进溃疡愈合作用^[3]。本研究用黄芪建中汤加味联合奥美拉唑治疗消化性溃疡脾胃虚寒型效果较好, 报道如下。

1 临床资料

共70例, 均为2021年3月至2022年3月我院门诊患者, 随机分为两组各35例。观察组男19例, 女16例; 年龄24~62岁, 平均 (39.45 ± 9.56) 岁; 病程1~23个月, 平均 (3.5 ± 1.2) 个月。观察组男20例, 女15例; 年龄25~61岁, 平均 (41.2 ± 8.65) 岁; 病程2~22个月, 平均 (3.4 ± 1.1) 个月。两组一般资料比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

诊断标准: ①参照《中医内科学》胃脘痛诊断标准^[4]。主症为胃脘部疼痛、空腹痛重、吐水泛吐、舌质肥大、舌苔薄白, 次症为畏寒肢冷、痞满、头晕肢倦、脉沉细。②参照《消化性溃疡的中西医结合诊治方案》^[5], 存在上腹部周期性节律性疼痛, 出现腹胀反酸, 活动期存在上腹部局限性压痛, 胃镜检查可见消化性溃疡病灶区域。

纳入标准: 符合中西医诊断标准, 排除幽门螺杆菌阳性, 经胃镜检查确定胃溃疡活动期, 溃疡面直径3~20mm, 患者治疗依从性良好, 签署同意书。

排除标准: 不属于脾胃虚寒证, 存在胃底部溃疡, 曾有胃部手术史, 患有胃泌素瘤、肝硬变导致的胃及十二指肠溃疡, 严重心脑血管肾功能异常, 妊娠及哺乳期, 对研究治疗药物过敏。

[基金项目] 河南省中医药科学研究专项课题 (20-21ZY2090)

2 治疗方法

两组均用奥美拉唑肠溶胶囊 (阿斯利康制药生产) 20mg, 每天2次口服, 治疗4周。

观察组加用黄芪建中汤。黄芪60g, 大枣、党参各30g, 白术、白芍、枳壳各20g, 桂枝、槟榔、紫苏叶、法半夏、茯苓、生姜各15g。便秘严重加枳壳、桃仁、当归行气健脾、养血通便, 腹中冷痛加吴茱萸、川椒目、制附片温中止痛, 伴口苦吐酸苔厚腻加吴茱萸、黄连以清肝火、止痛制酸, 伴失眠易惊加生牡蛎、生龙骨定惊安神。加水浸泡30min后煎煮30min, 取汁200mL, 三餐前服用, 日1剂, 治疗4周。

3 观察指标

以《中药新药临床研究指导原则》证候分级^[6], 中医证候正常、轻、中、重评为0分、2分、4分、6分, 中医证候包括胃脘疼痛、泛吐酸水、痞满、身重困倦、畏寒肢冷。

采用酶联免疫吸附试验测定细胞因子, 白细胞介素-6 (IL-6)、白细胞介素-2 (IL-2)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)。

胃镜复查根据炎症细胞浸润程度、黏膜形态、中性黏液含量进行分级评分, 正常、轻度、中度、重度分别记0、1、2、3分。

用SPSS20.0软件进行分析, 计量资料用 t 检验, 计数资料用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

4 疗效标准

按《中药新药临床研究指导原则》。临床控制: 胃痛泛酸临床症状消失, 胃镜检查溃疡面全部愈合。显效: 临床症状分级降低, 胃镜检查溃疡面缩小75%以上, 但局部病灶存在炎症。有效: 治疗后中医积分降低, 胃镜检查溃疡面缩小超过50%。无效: 中医积分未减少, 胃镜检查溃疡面缩小低于50%。

5 治疗结果

两组治疗前后细胞因子水平比较见表1。

2022, 33 (6): 510-517.

[17] 杨文志, 潘锡伟, 甘海芳. 加减仙方活命饮治疗重度痤疮的疗效及与血清IL-1 α 和IL-4表

达的相关性分析[J]. 广州中医药大学学报, 2022, 39 (7): 1536-1541.

[收稿日期] 2023-06-07